

ENFERMEDAD DE LYME

Pilar Cuesta Fuente, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Lyme está causada por la espiroqueta *Borrelia burgdorferi*, que es transmitida por la picadura de una o varios de los 4 tipos de garrapata (figura 1), generalmente del género *Ixodes*, de distribución mundial:

- *Ixodes scapularis*: la garrapata del ciervo en el noreste y centro de Estados Unidos.
- *Ixodes pacificus*: *Ixodes pacificus* (costa occidental de los Estados Unidos).
- *Ixodes ricinus* en Europa
- *Ixodes persulcatus* en Asia.

Los huéspedes de estas garrapatas son fundamentalmente pequeños roedores y otros mamíferos silvestres (ciervos) y domésticos (perros y gatos). El ser humano también puede ser parasitado, dando lugar a una enfermedad que cursa en estadios y con manifestaciones clínicas multisistémicas que afectan a la piel, articulaciones y sistema nervioso.



Figura 1

DIAGNÓSTICO

Manifestaciones clínicas

La enfermedad de Lyme suele comenzar con la fase de eritema migratorio (estadio 1) antes de diseminarse (estadio 2) y originar infección persistente (estadio 3):

Estadio 1 o infección temprana localizada

Después de un periodo de incubación de 3 a 32 días, aparece el denominado **eritema migrans o migratorio** (figura 2) en el sitio de la picadura de la garrapata (por lo común en muslo, ingle o axila) en el 80% de los pacientes. El cuadro clásico inicial incluye una mácula o pápula rojiza en la zona de la picadura, que se amplía poco a poco hasta formar una lesión anular con un borde rojo vivo y centro claro de varios centímetros. La *Borrelia burgdorferi* se disemina vía cutánea, linfática o hemática, ocasionando tras varios días o semanas el siguiente estadio: estadio 2



Figura 2

Estadio 2 o infección temprana diseminada

Algunos pacientes no perciben el eritema migratorio y acuden días o semanas después con lesiones cutáneas anulares secundarias, similares a la inicial, pero más pequeñas y con manifestaciones sistémicas inespecíficas, déficits neurológicos o bien manifestaciones cardíacas:

- **Manifestaciones inespecíficas:** incluyen cefalea, rigidez cervical, fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, malestar y fatiga. Suelen ceder en unas semanas.
- **Déficits neurológicos:** aparecen en el 15% de los pacientes e incluyen meningitis, encefalitis, inflamación de pares craneales, radiculoneuropatía motora y sensitiva, mononeuritis, ataxia o mielitis.
- **Manifestaciones cardíacas:** afectan al 8% de los pacientes, siendo los cuadros más comunes el bloqueo AV fluctuante y la miopericarditis aguda.

Estadio 3 o infección persistente

sucede en el 60% de los pacientes varias semanas o meses tras la primoinfección no curada y se caracteriza por ataques intermitentes de artritis oligoarticular de grandes articulaciones. También, con menos frecuencia, puede existir afectación del sistema nervioso, la memoria, el ánimo o el sueño. En Europa y Asia se observa acrodermatitis crónica atrófica como manifestación cutánea tardía.

Síndrome posterior a enfermedad de Lyme: meses o años después de haber sufrido la enfermedad, el 10% de los pacientes tienen dolor subjetivo, manifestaciones neurocognitivas o síntomas de fatiga.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en un cuadro clínico compatible asociado a antecedentes epidemiológicos de riesgo de exposición a garrapatas. El diagnóstico por serología es el más empleado. Se

recomienda una primera determinación serológica mediante **enzoinmunoanálisis (ELISA)** y su posterior confirmación mediante una prueba más específica como es el **Western-Blot**, considerando que habitualmente no se detectan las IgM frente a *Borrelia burgdorferi* hasta pasadas 3-4 semanas de la infección y las IgG tras 6-8 semanas. Las IgG e IgM pueden permanecer años después del tratamiento.

TRATAMIENTO

- **Doxiciclina 100mg:** 100 mg cada 12 horas durante 14-21 días (tratamiento de elección).
- **Amoxicilina 500** mg cada 8 horas o **cefuroxima 500** mg cada 12 horas durante 14-21 días si riesgo de exposición solar o en caso de embarazo.
- **Ceftriaxona** 2gr/ 24 h iv o **cefotaxima** 2gr/ 8 h iv durante 14-21 días en caso de enfermedad diseminada con afectación del SNC, carditis o artritis significativas.

El eritema desaparece a las dos semanas del inicio de la antibioterapia, el resto de síntomas pueden durar meses.

Es eficaz la protección de zonas expuestas, extirpación de la garrapata en las primeras 72 horas y aplicar repelentes de insectos.

PROFILAXIS

- **Doxiciclina 200mg** dosis única. El riesgo de infección por *Borrelia burgdorferi* después de una picadura comprobada de garrapata es tan pequeño que no está indicada sistemáticamente la profilaxis con antibióticos. Sin embargo si hay dudas o es difícil la vigilancia se puede evitar la enfermedad con una sola dosis de **200 mg de doxiciclina** en un plazo de 72 horas después de la picadura.

BIBLIOGRAFIA

- Nadelman R.B, Hanincovak, Mukherjee, Differentiation of reinfection from relapse in recurrent Lyme disease. N Engl J. Med. 2012.
- Diagnóstico y tratamiento médico Diagnostic Trade Mark, INC. 2010
- HARRINSON. Manual de Medicina.19 edición 2017. KASPER.FAUCI.HAUSE. LONGO. JAMESON. LOSCALZO
- Cardenas-de la Garza JA, De la Cruz-Valadez E, Ocampo-Candiani J, Welsh O. Clinical spectrum of Lyme disease. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Feb;38(2):201-208. doi: 10.1007/s10096-018-3417-1. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30456435.
- Van Hout MC. The Controversies, Challenges and Complexities of Lyme Disease: A Narrative Review. J Pharm Pharm Sci. 2018;21(1):429-436. doi: 10.18433/jpps30254. PMID: 30458921.
- Patton SK, Phillips B. CE: Lyme Disease: Diagnosis, Treatment, and Prevention. Am J Nurs. 2018 Apr;118(4):38-45. doi: 10.1097/01.NAJ.0000532071.32468.f7. PMID: 29543607.
- Treviño Castellano M, Navarro de la Cruz D, Trastoy Pena R. *Borrelia burgdorferi* serology and diagnosis of Lyme disease in the healthcare area of Santiago de Compostela (Galicia, Spain): 2006-2016. Med Clin (Barc). 2018 Aug 22;151(4):162-163. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2017.11.013. Epub 2017 Dec 9. PMID: 29233538.
- Guillén Martín S, Núñez Cuadros E, Tagarro García A, Calvo Rey C; en representación de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE) y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP). Posicionamiento de la AEP, la SERPE y la SEIP sobre el diagnóstico de la enfermedad de Lyme basado en la evidencia [Position statement of the AEP, SERPE, and SEIP on the evidence-based diagnosis of Lyme disease]. An Pediatr (Barc). 2019

Jul;91(1):66-67. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2019.04.018. Epub 2019 May 29. PMID: 31153796.

- Compendio de Medicina Interna. C. Rozman. Segunda Edición.
- Vázquez-López ME, Fernández G, Díaz P, Díez-Morrondo C, Pego-Reigosa R, Coira-Nieto A. Utilidad de los estudios serológicos en los centros de Atención Primaria para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Lyme [Usefulness of serological studies for the early diagnosis of Lyme disease in Primary Health Care Centres]. Aten Primaria. 2018 Jan;50(1):16-22. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2017.01.008. Epub 2017 May 2. PMID: 28476293; PMCID: PMC6836939.
- Bush L.M. Vazquez-Pertejo M.T. Manual MSD. Enfermedad de Lyme. <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/espiroquetas/enfermedad-de-lyme>